

EXAMEN CLINIQUE DE LA HANCHE ET DU GENOU

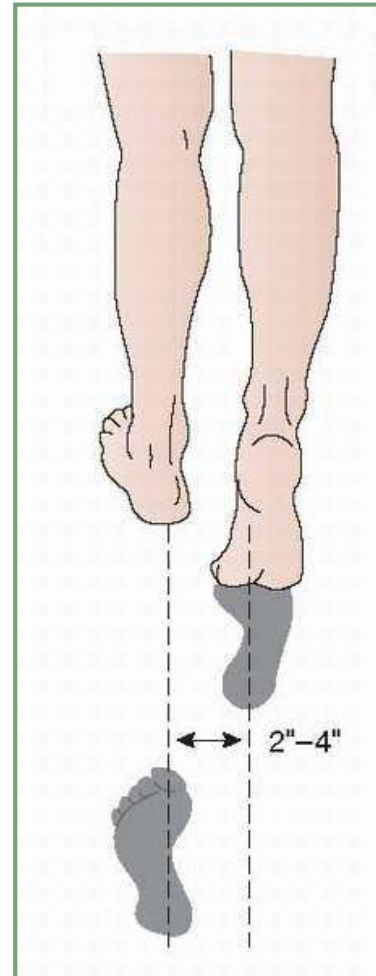
La réalisation de l'examen clinique de la hanche et du genou exige que le patient enlève son pantalon et ses chaussettes.

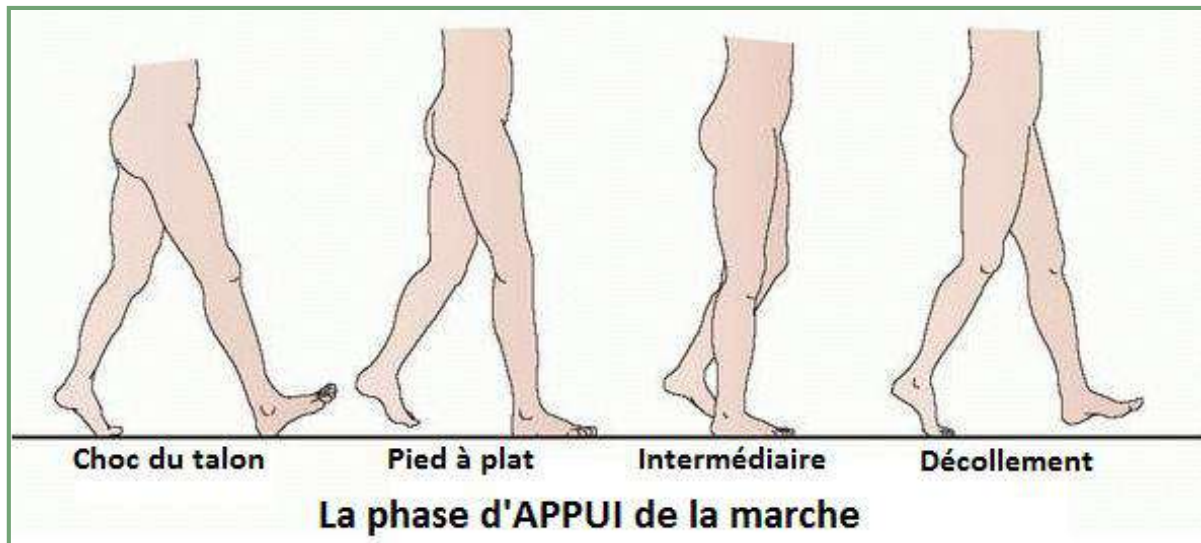
HANCHE

INSPECTION

Marche:

- Demander au patient d'effectuer quelques pas, de se retourner et de revenir vers l'examineur
- Observer la démarche:
 - Appui:
 - 60% du cycle de la marche
 - Lorsque le pied touche le sol et supporte le poids du corps.
 - La plupart des problèmes se manifestent durant la phase d'appui.
 - Balancement:
 - 40% du cycle
 - Lorsque le pied est projeté en avant et ne supporte pas le poids du corps.
- Observer:
 - Largeur de la base: environ de 5 à 10 cm. Un élargissement suggère une maladie cérébelleuse ou une atteinte des pieds.
 - La déviation du bassin: la contraction des abducteurs (du membre supportant le poids) stabilise le bassin et en élevant la hanche opposé permet le maintien de l'équilibre. Un abaissement controlatéral du bassin peut résulter d'une luxation de la hanche, un rhumatisme ou une faiblesse de abducteurs.
 - La flexion du genou: flexion durant tout l'appui sauf lorsque le talon heurte le sol. Une absence de flexion du genou provoque une marche disharmonieuse.
- Identifier une boiterie, une maladie de Duchenne ou un signe de Trendelenburg.
 - Boiterie de Duchenne: parésie des moyens et des petits fessiers. Elle se caractérise par un signe de Trendelenburg bilatérale. Le signe est dynamique.
 - Signe de Trendelenburg: lorsque le patient soulève sa cuisse du côté droit (flexion) pour pouvoir commencer à marcher, le bassin descend du côté droit car il n'est pas maintenu par le moyen et petit fessier. En conséquence, le rachis compense. C'est un signe statique (visible au repos) et unilatéral.





Membres inférieures:

- Demander au patient de se coucher en décubitus dorsal.
- Observer la lordose lombaire.
- Observer la symétrie des deux membres inférieurs.
- Rechercher des cicatrices
- Observer la longueur des membres inférieurs. Rechercher une différence de longueur.

Pour mesurer la distance, il existe deux techniques:

- Technique des plots: le patient est debout. L'examineur place des plots sous le pied du patient jusqu'à ce que les deux membres inférieurs soient au même niveau.
- Technique épine iliaque (la meilleure): l'examineur mesure la distance entre l'épine iliaque antéro-supérieure et la malléole interne. Cette technique est idéal pour les personnes qui ont de la peine à rester debout.



Ne pas confondre: dans le cas d'une fracture du col du fémur, la jambe serait plus court, légèrement tournée vers l'extérieur et douloureuse. Dans le cas d'une dislocation de la hanche, la jambe est tournée vers l'intérieur. Les déformations en abduction ou en adduction et les scolioses peuvent provoquer des changements de longueur.

PALPATION

L'examineur teste la stabilité du bassin et recherche une zone douloureuse indiquant fissure, une ouverture ou une inflammation d'une bourse.

Pour cela:

- Palper les épine iliaques bilatéralement.
- Palper les grands trochanters (dans le cas d'une douleur, penser à une bursite)
- Palper le pubis (je ne sais pas comment)
- Palper les ischions: il n'est pas nécessaire de palper les ischions. Une atteinte des ischions provoque des douleurs lorsque le patient s'assied.



Selon le Marieb	
Antérieur	Postérieur
Crête iliaque (L ₄) : bord supérieur du bassin	Epine iliaque postéro-supérieure (S ₂): au-dessus des fesses, sous les fossettes (creux)
Tubercule iliaque: suivre la courbure antérieure de la crête et identifier le point le plus large de la crête correspondant au tubercule iliaque.	Grand trochanter: Poser le pouce et l'index sur l'EIPS et localiser le grand trochanter avec les doigts situé latéralement au pli fessier.
Epine iliaque antéro-supérieure: à la suite du tubercule, en bas de la crête.	Tubérosité ischiatique: déplacer les pouces dans le pli fessier sur la tubérosité ischiatique.
Grand trochanter du fémur: maintenir les pouces sur les EIAS et glisser les doigts vers le bas jusqu'aux grands trochanters. Pour faciliter la palpation, demander au patient d'effectuer des rotations interne et externe; le grand trochanter suit le mouvement et glisse sous les doigts.	Articulation sacro-iliaque: non palpable
Symphyse pubienne: déplacer les pouces depuis les EIAS vers la symphyse pubienne tout en maintenant les doigts sur les grands trochanters	

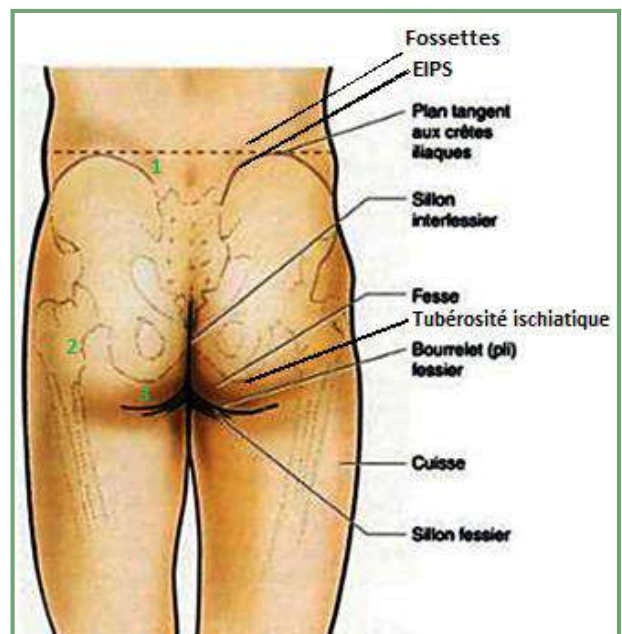
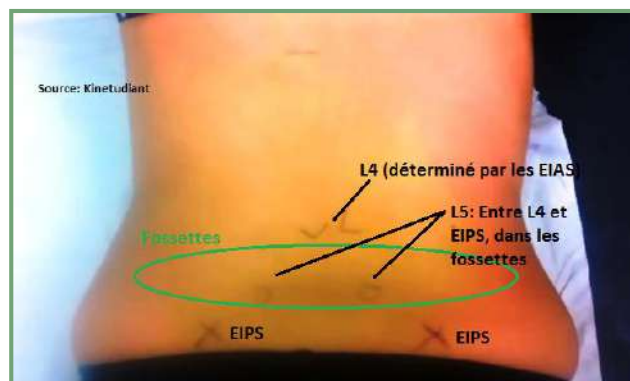
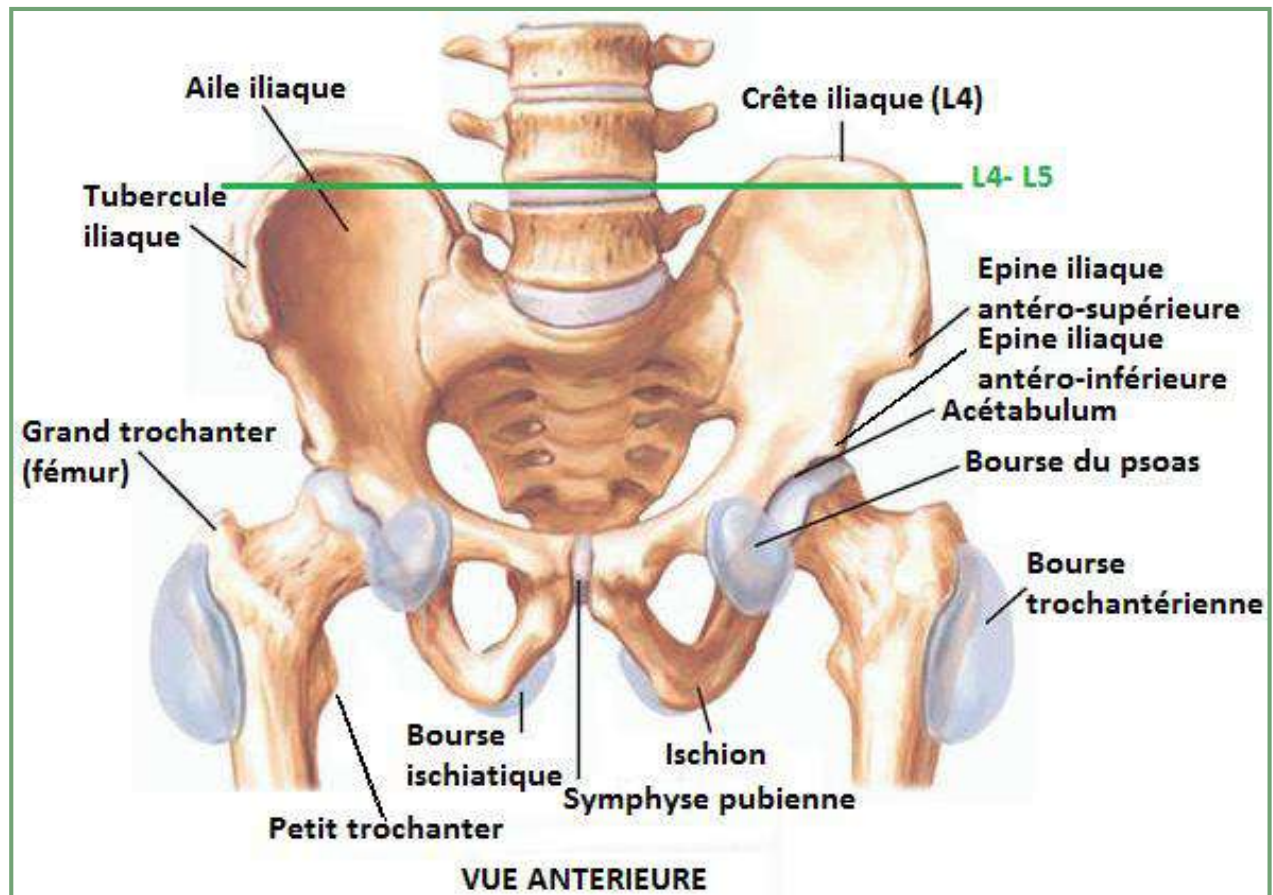


Figure 5.20. Région glutéale — la région de la fesse. Le sillon interfessier sépare les fesses (proéminences glutéales). Le sillon fessier (pli fessier) est le sillon sous-jacent au bourrelet fessier ; il est croisé par le bord inférieur du muscle grand fessier. Le sillon fessier marque la limite entre la fesse et la cuisse.

MOUVEMENT

Attention: demander au patient s'il a eu une opération des membres inférieurs, des antécédents ou une prothèse. En effet, une rotation interne ou un croisement de jambes chez un patient disposant d'une prothèse de hanche peuvent être très dangereux. En conséquence, il est important de vérifier la présence de cicatrice.

Flexion (150-170°) et extension de la hanche

Le patient fléchit le genou et le ramène vers la poitrine en le tirant vers l'abdomen..
L'examineur place la main sous le rachis lombaire:

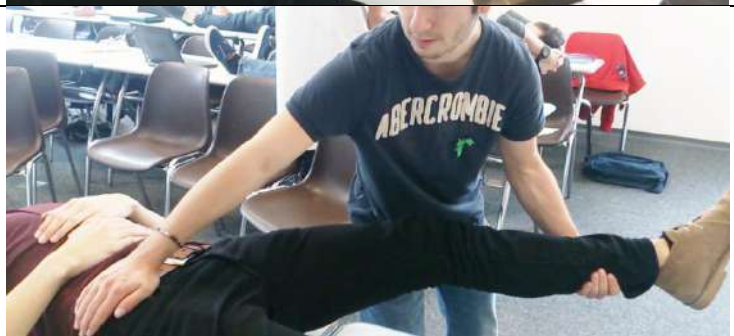


Rotations interne et externe (l'arthrose touche en premier lieu la rotation interne de la cuisse)



Abduction et adduction

NB: L'abduction maximale est atteinte lorsque l'examineur sent un déplacement de l'épine iliaque antéro-supérieure. Il ne faut pas évaluer l'abduction ni en cas de dislocation de la hanche ni en cas de fracture du fémur.



GENOU

INSPECTION

Rechercher:

- Une démarche irrégulière:
 - Le genou doit être étendu lorsque le talon frappe le sol et fléchi durant les autres phases.
 - Faiblesse du quadriceps: aide à l'extension lorsque le talon frappe le sol
- Des cicatrices
- Une inflammation
- Un valgus ou un varus (r come jambe en rond)
- Un épanchement:
 - Bursite pré-rotulienne: tuméfaction sur la rotule
 - Bursite sous-rotulienne: tuméfaction sur la tubérosité tibiale
 - Bursite ansérine: tuméfaction interne

PALPATION

Articulation tibio-fémorale:

- Placer les pouces dans les dépressions situées de chaque côté du tendon rotulien.
- Enfoncer les pouces vers le bas, jusqu'à sentir la bordure du plateau tibial. Au-dessus se situe l'interligne fémoro-tibiale.

Palpation des Ménisques:

- Le patient fléchit la jambe (la flexion de la jambe déplace les ménisques en avant).
- L'examineur recherche l'interligne fémoro-tibiale médiale qui se situe en-dessous de la patella.
- Il palpe ensuite cette interligne antérieurement avec les pouces à l'affût d'une zone douloureuse indiquant une déchirure méniscale post-traumatique.
NB: Il est plus facile de palper le ménisque médial si le tibia est légèrement en rotation interne. Il est plus facile de palper le ménisque latéral si le tibia est légèrement en rotation externe.
- L'examineur déplace ses pouces depuis l'interligne fémoro-tibiale



supérieurement pour localiser les condyles fémoraux et identifier une éventuelle fracture.

- L'examineur palpe le long de l'interligne fémoro-tibiale pour localiser l'insertion des tendons au niveau du genou.

Test du glaçon:

- L'examineur vide les bourses supra-patellaire et infra-patellaire de manière à réunir tout l'épanchement au-dessus de la patella. Pour cela il place ses mains sur la jambe et la cuisse et les ramène, tout en comprimant, vers la patella.
- L'examineur appuie avec un doigt sur la patella.
- Le test est positif lorsque le doigt s'enfonce sur la patella puis touche l'os avec une sensation de "clic". Il y a un épanchement au niveau du membre inférieur. Le test est négatif lorsque le doigt ne s'enfonce pas ou touche directement l'os.
- Attention: il est important de maintenir les mains en compression sur la jambe lorsque l'examineur réalise le test. Dans le cas contraire, l'épanchement peut s'échapper conduisant ainsi à un faux-négatif.



MOUVEMENT

L'examineur évalue la fonction des différents ligaments.

Test du tiroir:

1. Placer le genou à angle droit.
2. Poser le pieds à plat.
- 3.
4. S'asseoir sur le pied de manière à éviter un éventuel glissement du pied.
5. Placer les doigts dans le creux poplité sauf les pouces, antérieurement. L'examineur tire la jambe vers soi. Le test du tiroir antérieur (ligament croisé antérieur) est positif si le genou présente une laxité lors de la traction.
6. L'examineur pousse la jambe. Le test du tiroir postérieur (ligament croisé postérieur) est positif si le genou présente une laxité lors de la poussée.



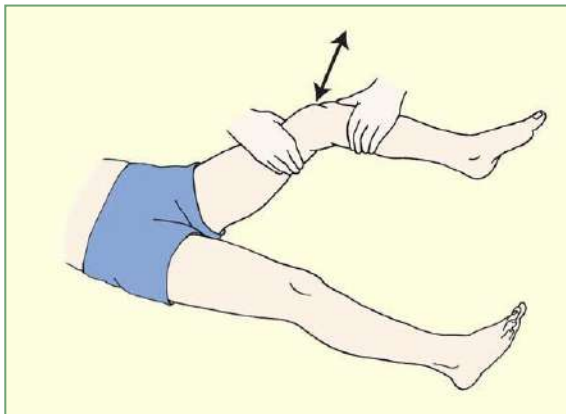
Symétrie de tubérosités tibiale (autre test pour le ligament postérieur):

- Le patient place ses membres inférieurs à angle droit. L'examineur observe la hauteur des tubérosités tibiales de chaque membre et détermine si elles se situent à la même hauteur. Un abaissement, d'un des côtés, de la tubérosité tibiale indique un défaut du ligament croisé postérieur.

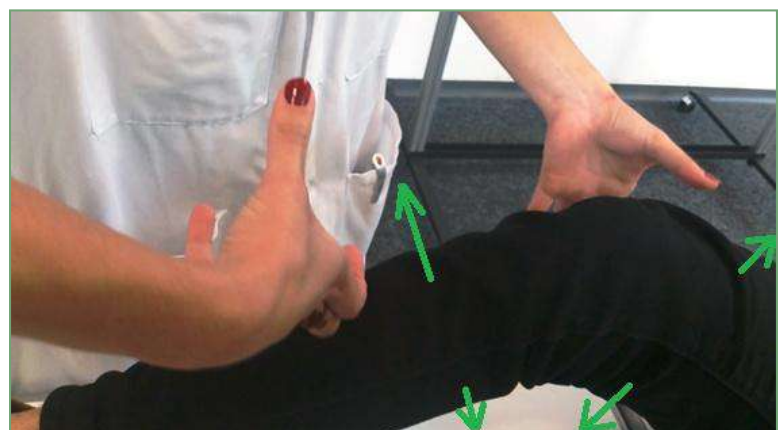


Test de Lachman (autre test pour le ligament croisé antérieur):

- L'examineur soulève le pied et fléchit la jambe du patient de manière à obtenir un angle de 15-30° et en rotation externe. Le membre inférieur n'est pas à angle droit et le pied n'est pas à plat sur la table.
- Il place une main sur la partie interne de la jambe (mollet) et l'autre sur la cuisse externe. Le pouce de la première main est placé sur l'interligne articulaire.

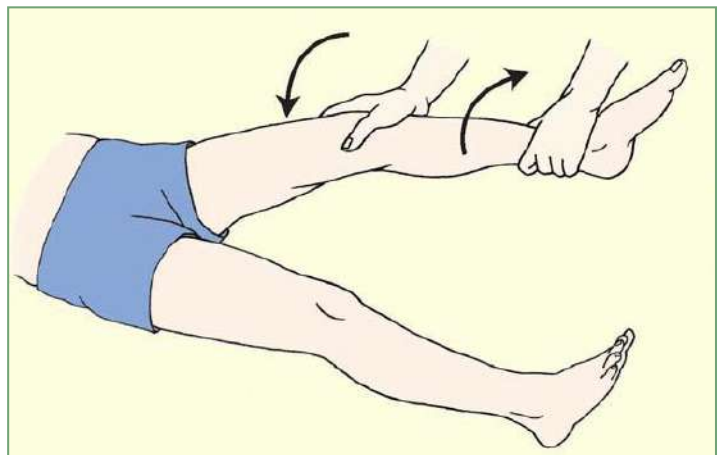
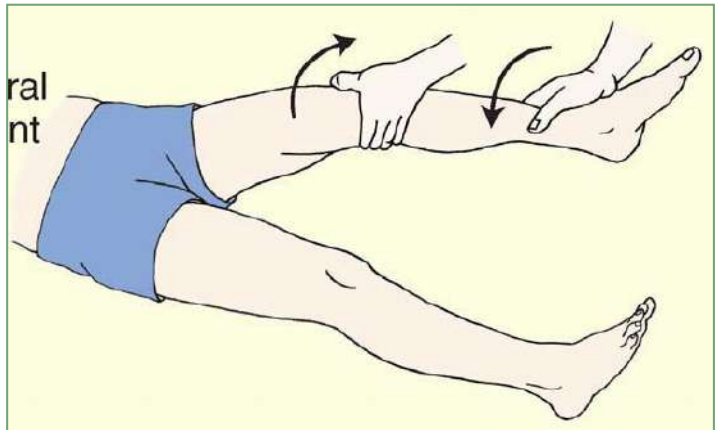
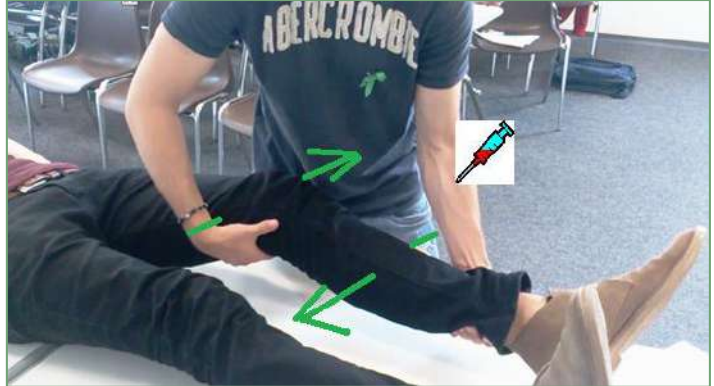


- L'examineur exécute un mouvement en avant- en arrière, en déplaçant le tibia en avant et le fémur en arrière afin de bloquer les ligaments. Il évalue la laxité et notamment le degré de déplacement en avant. Une avancée importante indique une déchirure du ligament croisé antérieur.



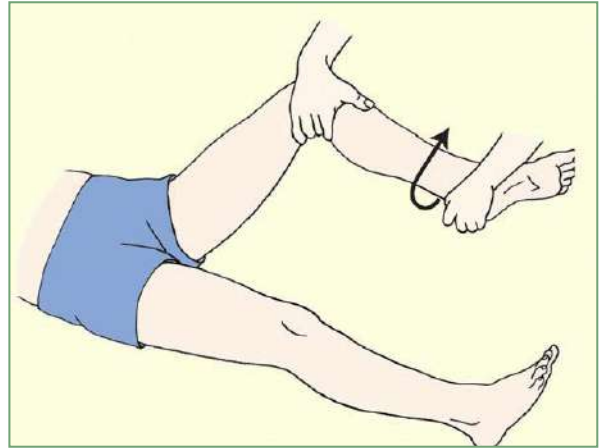
Ligaments collatéraux:

- L'examineur évalue la stabilité des ligaments collatéraux. Pour cela, il met en tension les ligaments. Le résultat est négatif lorsque le ligament est en tension contre les mouvements. Il est positif lorsque des mouvements sont possibles ou bien si le patient ressent une douleur.
- Le patient est couché sur le dos, le genou légèrement fléchi et sa cuisse est écartée de 30° vers le bord de la table.
- Ligament latéral externe:
 - L'examineur place une main sur la partie interne du genou pour stabiliser le fémur. L'autre main est placée autour de la partie externe de la cheville.
 - L'examineur exécute une varus sous tension. Il pousse le genou extérieurement (en dehors) et tire la cheville intérieurement (en dedans).
- Ligament latéral interne:
 - L'examineur place une main sur la partie externe du genou pour stabiliser le fémur. L'autre main est placée autour de la partie interne de la cheville.
 - L'examineur exécute une valgus sous tension. Il pousse le genou intérieurement (en dedans) et tire la cheville extérieurement (en dehors).



Ménisques

- Une lésion des ménisques notamment une déchirure postérieure provoque une douleur à la compression ou un clic articulaire (claquement) pendant la flexion et l'extension du genou.
- La patient est couché sur le dos. L'examineur place une des ses mains sur le talon et l'utilise pour fléchir le genou.
- L'examineur place les doigts de son autre main sur le ménisque interne, le long de l'interligne articulaire.. Puis, il effectue une rotation externe du genou et une flexion. Le ménisque est lésé, une douleur surgit.
- Pour tester le ménisque externe, l'examineur tourne la jambe , un peu, vers l'extérieur. Il bloque le ménisque externe en le comprimant avec sa main. L'examineur effectue des mouvements de flexion et extension.
- Pour tester le ménisque interne, l'examineur tourne la jambe du patient , un peu, vers l'intérieur. Il bloque le ménisque interne en le comprimant avec sa main. L'examineur effectue des mouvements de flexion et extension.



Autre test:

- Le patient se place en décubitus ventral. Il fléchit une des jambes à angle droit.
- Pour évaluer le ménisque interne, l'examineur tourne le pied vers l'intérieur puis appuie fortement, verticalement, sur le pied. Si le patient ressent une douleur, le ménisque est lésé.
- Pour évaluer le ménisque externe, l'examineur tourne le pied vers l'extérieur puis appuie fortement, verticalement, sur le pied. Si le patient ressent une douleur, le ménisque est lésé.

